

CAPÍTULO 9.11

Alteraciones de la Hemostasia

PERFIL EUNACOM 1.07.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hemostasia: Generalidades y Clasificación

Hemostasia Primaria vs. Secundaria

TABLA 9.11.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	HEMOSTASIA PRIMARIA (PLAQUETAS)	HEMOSTASIA SECUNDARIA (COAGULACIÓN)
Componente	Plaquetas	Factores de coagulación
Sangrado típico	Petequias, mucosas, epistaxis , gingivorragia	Hematomas profundos, hemartrosis
Examen alterado	Tiempo de sangría	Tiempos de coagulación (TTPK o TP/INR)

Clínica diferencial

TABLA 9.11.2: ALTERO PRIMARIA VS ALTERO SECUNDARIA	
ALTERO PRIMARIA	ALTERO SECUNDARIA
Petequias	Hematomas profundos
Equimosis superficiales	Hemartrosis
Sangrado de mucosas	
Alveolorrhagia (sangrado en extracción dental)	
Epistaxis, hipermenorrea	

Exámenes

TABLA 9.11.3: PROBLEMA VS EXAMEN ALTERADO	
PROBLEMA	EXAMEN ALTERADO
Hemostasia primaria	Tiempo de sangría ↑
He secundaria — vía intrínseca	TTPK ↑ → hemofilia , heparina
Hemostasia secundaria — vía extrínseca	TP/INR ↑ → daño hepático, cumarínicos
CID	Todo alterado (plaquetas ↓ + TTPK ↑ + TP ↑)

Clasificación de alteraciones primarias

TABLA 9.11.4: PLAQUETAS ↓ (TROMBOCITOPENIA) VS PLAQUETAS NORMALES (DISFUNCIÓN PLAQUETARIA)	
PLAQUETAS ↓ (TROMBOCITOPENIA)	PLAQUETAS NORMALES (DISFUNCIÓN PLAQUETARIA)
PTI, PTT, leucemia, aplasia medular, mielodisplasia	Von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier, AINes

Púrpura

- **Definición clínica:** lesiones cutáneas que **no blanquean** con la compresión
- Incluye petequias y equimosis
- Primer examen → **hemograma** (¿hay trombocitopenia?)

EUNACOM CRITERIOS

Púrpura febril = urgencia → sospechar meningococemia, CID o vasculitis ANCA. Hospitalizar de inmediato.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 25 años consulta por epistaxis frecuentes, gingivorragia al cepillarse los dientes y petequias en piernas. Examen: petequias y equimosis cutáneas múltiples, sin esplenomegalia ni hemartrosis. Tiempo de sangría prolongado, recuento plaquetario 35.000/mm³, TP y TTPA normales."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Trastorno de la Hemostasia Primaria: caracterizado por hemorragias mucocutáneas superficiales (petequias, púrpura, epistaxis, metrorragia) y alteración plaquetaria / tiempo de sangría. En contraste, los trastornos de la hemostasia secundaria (factores de coagulación como hemofilia) producen hematomas musculares profundos y hemartrosis con alteración del TP o TTPA.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La hemostasia primaria (plaquetas) produce petequias y sangrados de mucosas; la secundaria (coagulación) produce hematomas y hemartrosis
- El tiempo de sangría se alarga en alteraciones de hemostasia primaria
- Los tiempos de coagulación (TTPA, TP) se alteran en hemostasia secundaria
- Trombocitopenia: PTI, PTT, leucemia, aplasia medular. Disfunción plaquetaria: von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier
- TTPA alargado: hemofilia o intoxicación por heparina
- TP alargado (INR elevado): daño hepático crónico o intoxicación por cumarínicos
- La alveolorrhagia (sangrado post-extracción dental) es característica de alteraciones de hemostasia primaria
- En CID se altera todo: plaquetas bajas y ambos tiempos de coagulación alargados

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA)

PREGUNTA 1

Paciente con petequias generalizadas, epistaxis recurrente y gingivorragia. ¿Cuál es el tipo de alteración de la hemostasia más probable?

- A)** Alteración de hemostasia secundaria
- B)** Alteración de hemostasia primaria
- C)** Coagulación intravascular diseminada
- D)** Deficiencia de vitamina K
- E)** Hemofilia

PREGUNTA 2

Paciente con hemartrosis de rodilla y hematomas profundos en muslos. El TTPA está alargado y el TP es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** PTI
- B)** Enfermedad de von Willebrand
- C)** Hemofilia
- D)** Daño hepático crónico
- E)** Intoxicación por cumarínicos

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes hallazgos es MÁS específico de una alteración de la hemostasia primaria?

- A)** Hematoma profundo
- B)** Hemartrosis
- C)** Equimosis
- D)** Petequias
- E)** TTPA alargado

RESUMEN: ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA

Esta clase introduce las generalidades de las alteraciones de la hemostasia, diferenciando entre hemostasia primaria (plaquetas) y hemostasia secundaria (sistema de coagulación). Ambas tienen clínica y exámenes distintos. La hemostasia primaria se manifiesta con petequias, equimosis y sangrados de mucosas (gingivorragia, epistaxis, hipermenorrea, hematuria, hemorragia digestiva, alveolorragia). Lo que se altera es el tiempo de sangría. Puede ser por trombocitopenia (PTI, PTT, leucemia, aplasia medular) o por disfunción plaquetaria con plaquetas normales (enfermedad de von Willebrand, Glanzmann, Bernard-Soulier, AINEs). La hemostasia secundaria se manifiesta con hematomas profundos y hemartrosis. Según qué tiempo de coagulación se alargue: TTPA alargado sugiere hemofilia o intoxicación por heparina; TP alargado (protrombinemia baja/INR elevado) sugiere daño hepático crónico o intoxicación por cumarínicos. En la CID se altera todo: plaquetas bajas y ambos tiempos de coagulación alargados.